

YH560A 225210174

LUIZ ANTONIO LUCIO	
MEDICAMENTOS:	Desordane / allopodina
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência ao dirigir /
BANHEIRO	1x
HORA QUE ACORDA	23h
HORA QUE DORME	06:30
Respiração	Mista (+ boca)
PRÁTICA EXERCÍCIO	faz corrida / futebol
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE: <u>sim</u>	ALMOÇO: <u>sim</u> LANCHE: <u>sim</u> JANTA: <u>—</u>
26/12	P = autom p/ titular
22	
02/01	P = 10 cmH ₂ O passo p/ pressão fixa.
23	IAH = 9.4 e/ev m. de uso: 7h
	fixa.
18/01	P = 10 cmH ₂ O ↑ a pressão p/ 11 cmH ₂ O
23	IAH = 10 e/ev.
	m. de uso:
	Fuga = 14 lpm
	fixa.
01/02	P = 11 cmH ₂ O
23	IAH = 9.3 e/ev
	m. de uso = 4h43
	Relata que ainda está af dificuldade
	para aprof. o sono.
	Volta para APAP.
15/02	P: 10.3 Pmin 7.6 Auto 10-6
2023	IAH: 12.1 ↑ confab 3
	m. de uso: 5h18
22/03	
2023	Passou para fixa 9.0 cmH ₂ O
	IAH = 14
18/05	P = 9.0 cmH ₂ O ↑ P = 9.5 cmH ₂ O
23	IAH = 6.1 e/ev
	m. de uso: 5h27
	Bem adaptado, porém ele está desper
	taando devido o ronco da esposa.
	fixa
10/06/23	P = 9.3 cmH ₂ O
	IAH = 8.2
	m. de uso: 6 horas
	Bem adaptado
	sugiro atividade física

19/07 2023 P = 9,3 cmH₂O P₉₀: 9,5 cmH₂O
IAH = 6,5 e/ev
m. de uso: 5h45 37 min
fuga = 7,6 l/min
⇒ caminhada diária
nonce espera - atrapalha sono
AP: 30 cmH₂O.

29/08 23 P = 9,8 cmH₂O
m. de uso: 6h
IAH = 6 e/ev
melhora do sono.
alguns dias bebeu.

22/01 25 P = 10,5 cmH₂O
IAH = 0,1 e/ev
m. de uso: 5h45
fuga = 19,7 lpm.
8-18hs Trabalho

flua Cláudio

13/02 25 P = 10, cmH₂O
IAH = 2,2 e/ev
m. de uso: 5h20'
fuga = 5,5 lpm.

ainda usando o esparadra
pe.

flua.

23/05/25 P = 10,5 cmH₂O
IAH = 2,7 e/ev
m. de uso: 5h19'
fuga: 39,3 l/m

Ajuste máscara

Natália

27/06 25 P = 10 cmH₂O
m. de uso: 5h36'
IAH = 2,3 e/ev
fuga = 4,4 lpm

flua

Nome: LUIZ ANTONIO LUCIO
Data de Nascimento: 19-1-1973
IMC: 31,92
Sexo: Masculino
Data do exame: 16-11-2022

Peso: 100 kg
Altura: 1,77 m
Médico: DRA. FLAVIA K. S. OLIVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-11-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 526,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 118,0 e 138,0 minutos. O tempo total de sono foi de 295,5 min, eficiência de 56,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 70,4%; estágio N3: 5,6%; sono REM: 21,2%. O índice de despertares foi de 38,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 87,7/hora, sendo 86 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 77 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 68%, permanecendo 11,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 93 bpm e NREM de 56 - 92 bpm.

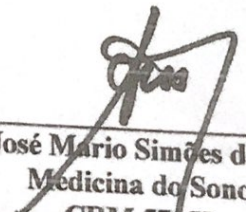
CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 87,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=68%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (0,8/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157